



Les artériopathies oblitérantes des membres inférieurs

Dr kaghouché houda
Maitre assistante en cardiologie CHU ibn BADIS

Objectifs pédagogiques

- ▶ Connaître les principales étiologies des AOMI
- ▶ Reconnaître les symptômes cliniques
- ▶ Savoir hiérarchiser les différentes explorations
- ▶ Planifier la PEC d'une AOMI

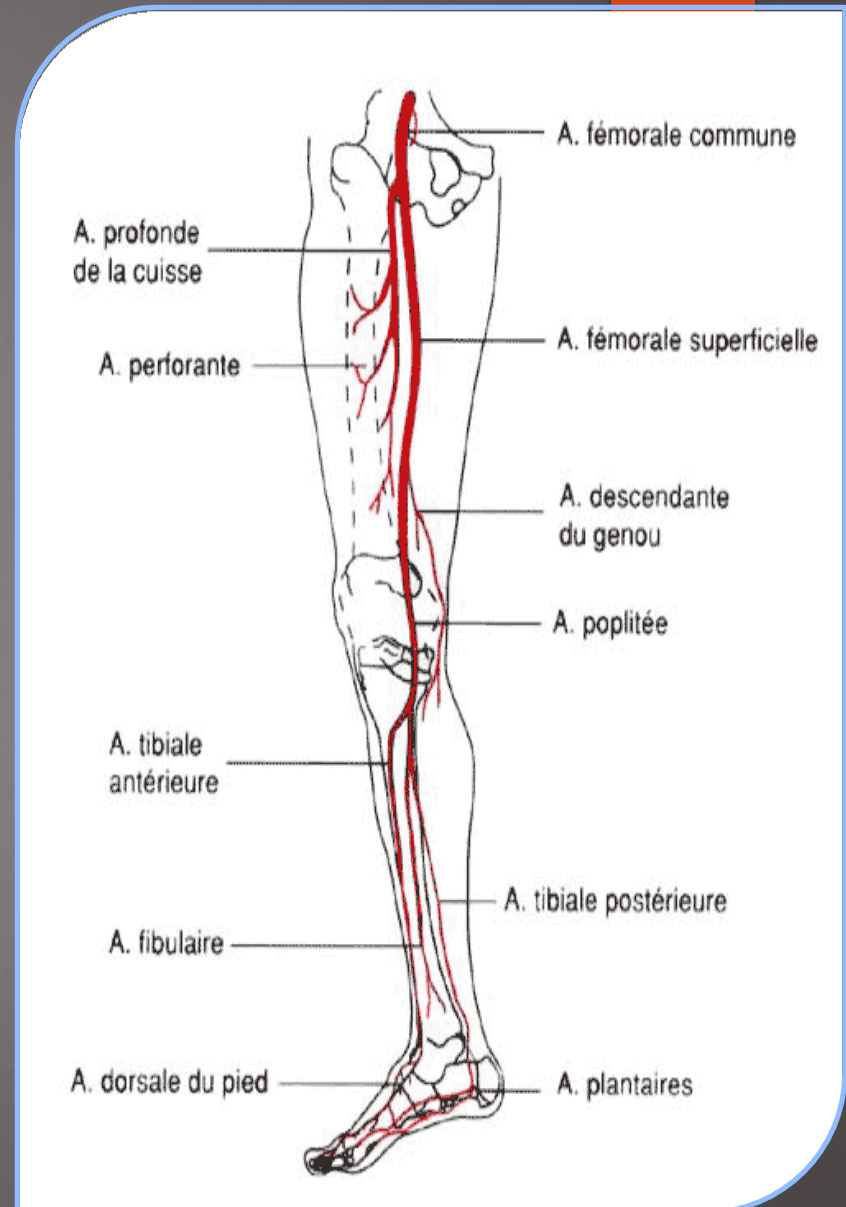
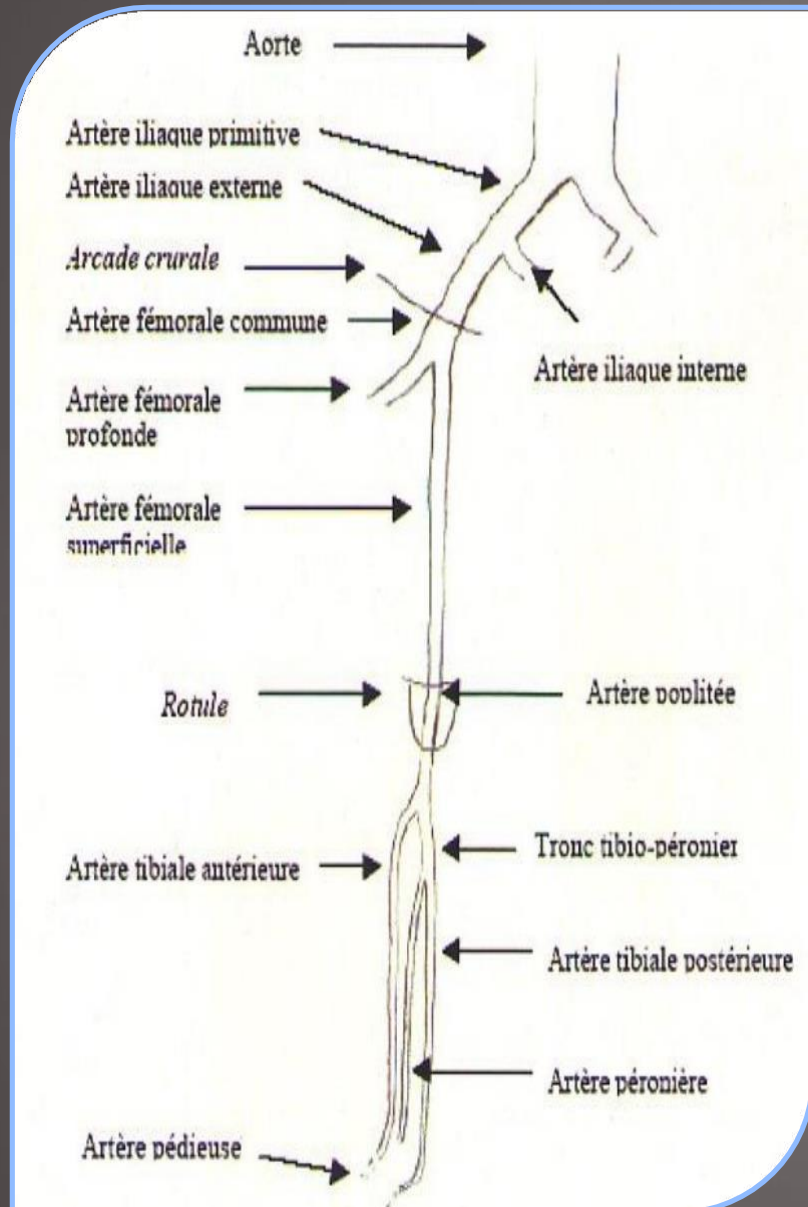
plan

- ▶ Introduction/Définition
- ▶ Etiologie
- ▶ Epidémiologie
- ▶ Anatomopathologie
- ▶ Physiopathologie
- ▶ Diagnostic positif
- ▶ Examens complémentaires
- ▶ Formes cliniques
- ▶ Diagnostic différentiel
- ▶ Complication
- ▶ Traitement
- ▶ Conclusion

I. Introduction

- Affection artérielle principalement d'origine **athéromateuse**, entraînant un rétrécissement
 - ▶ **progressif** des artères pouvant aboutir à leur oblitération complète.
 - Le diagnostic repose sur l'interrogatoire, l'examen clinique et la mesure de l'IPS, confirmé par l'écho doppler.
 - Le traitement médical : toujours indispensable
 - Le traitement chirurgical : en cas d'ischémie permanente.

II. Rappel anatomique



III. Etiologie :

- A. **L'athérosclérose** : 95 % des cas
- B. **Les maladies inflammatoires** : la maladie de Buerger, la maladie de Takayashu et les collagénoses.
- C. **Les causes infectieuses.** : le syphilis, les rickettsioses

IV. Épidémiologie

A. La prévalence:

1% avant 50ans  7% après 65ans

B. Facteurs de risque de l'athérosclérose :

- ✓ Age
- ✓ Sexe masculin
- ✓ Tabac ++++
- ✓ Diabète
- ✓ dyslipidémie
- ✓ Hypertension artérielle
- ✓ Sédentarité
- ✓ Obésité

V. Anatomopathologie

Dépôt lipidiques microscopique de l'intima

Stries lipidiques macroscopiques peu saillante

Plaque athéromateuse

Ulcérée

Embolie de
cristaux de cholestérol

Oblitération du lit
d'aval

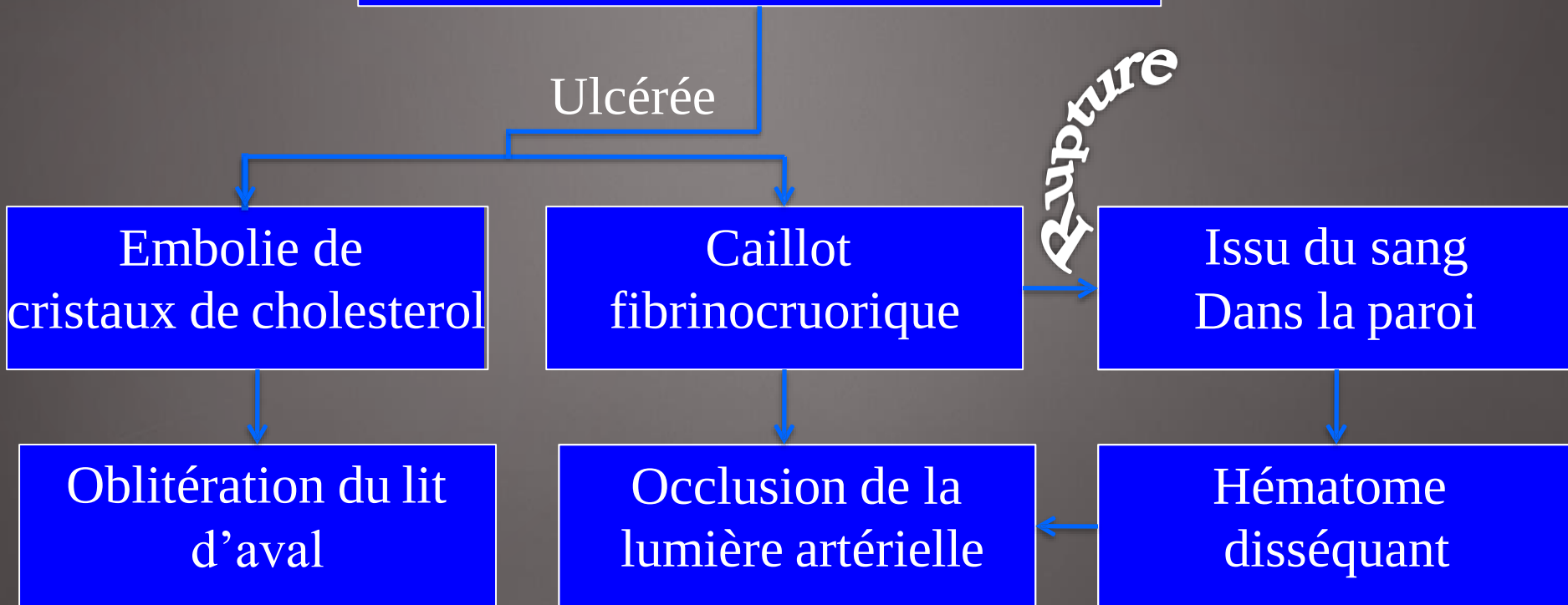
Caillot
fibrinocruorique

Occlusion de la
lumière artérielle

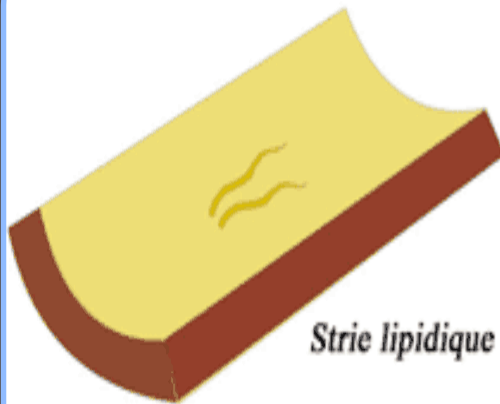
Rupture

Issu du sang
Dans la paroi

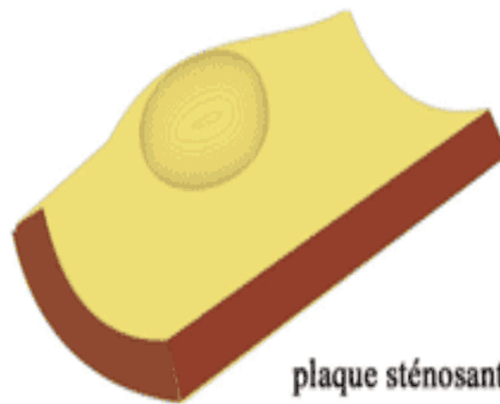
Hématome
disséquant



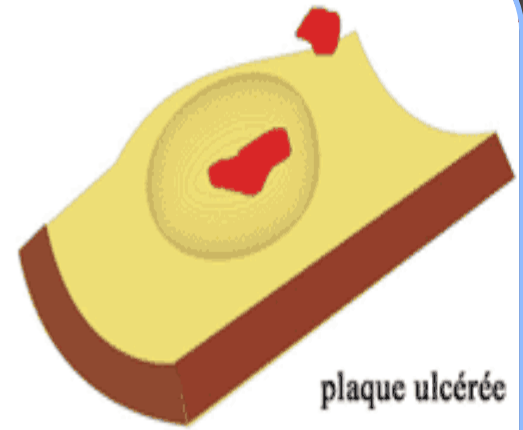
anatomo-pathologie de la plaque athéromateuse



Strie lipidique



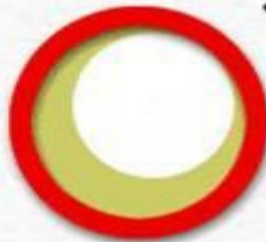
plaque sténosante



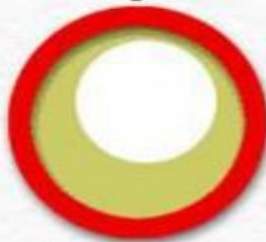
plaque ulcérée

Rupture de la plaque

Plaque d'athérosclérose



Incorporation
avec progression
de la sténose



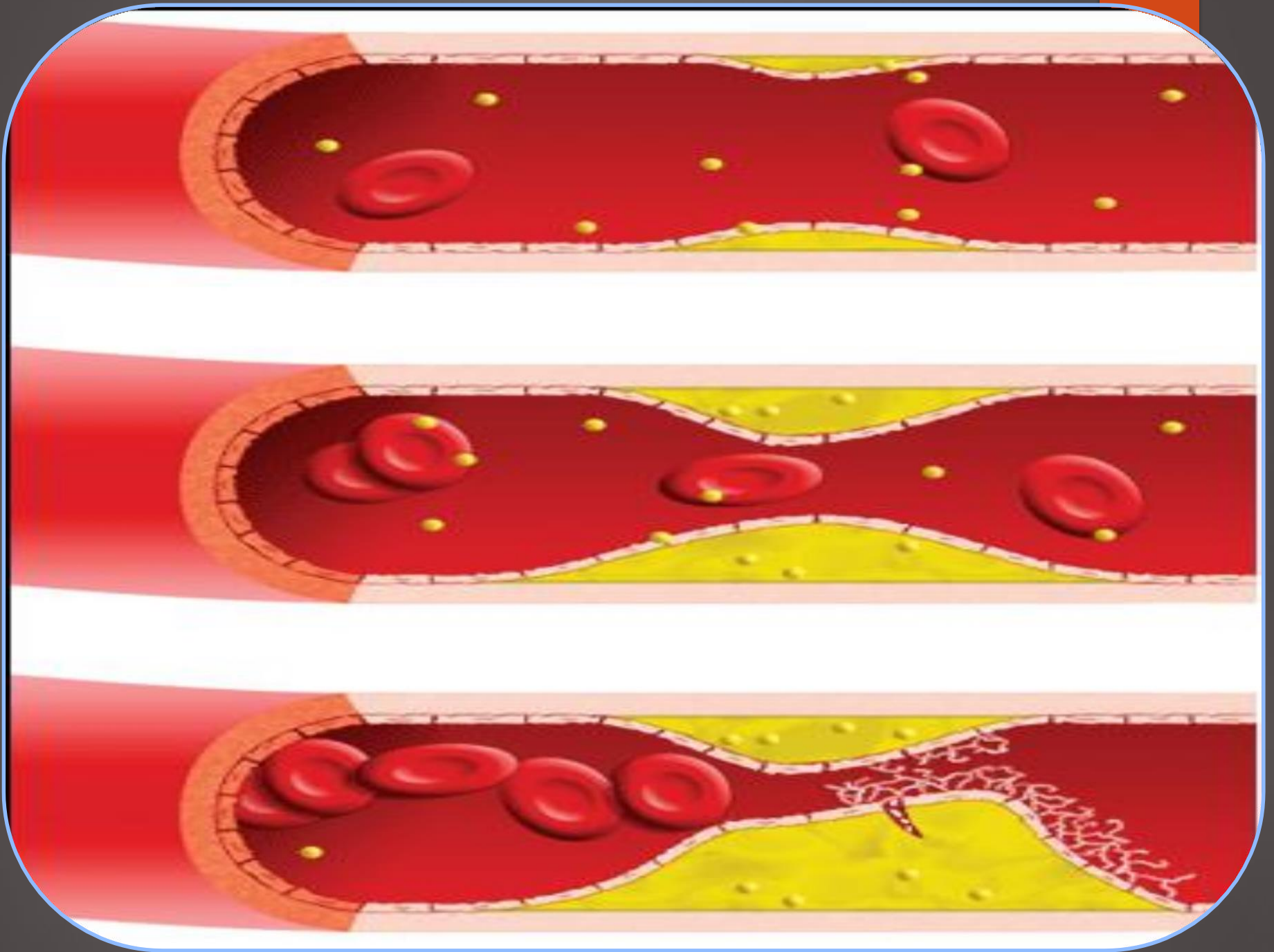
Thrombose sur ulcération
et hématome intraplaque



VI. Physiopathologie



- Au début, le retentissement hémodynamique des lésions artérielles est minime: le patient est **asymptomatique**
- Puis lors d'un effort, le flux sanguin est réduit entraînant une souffrance tissulaire d'effort : **ischémie d'effort**.
- L'évolution se fait parfois vers une souffrance tissulaire permanente, le flux sanguin étant très réduit : **ischémie permanente**.
- Le développement de la collatéralité artérielle : réinjecter le lit artériel en aval de la zone atteinte ++++



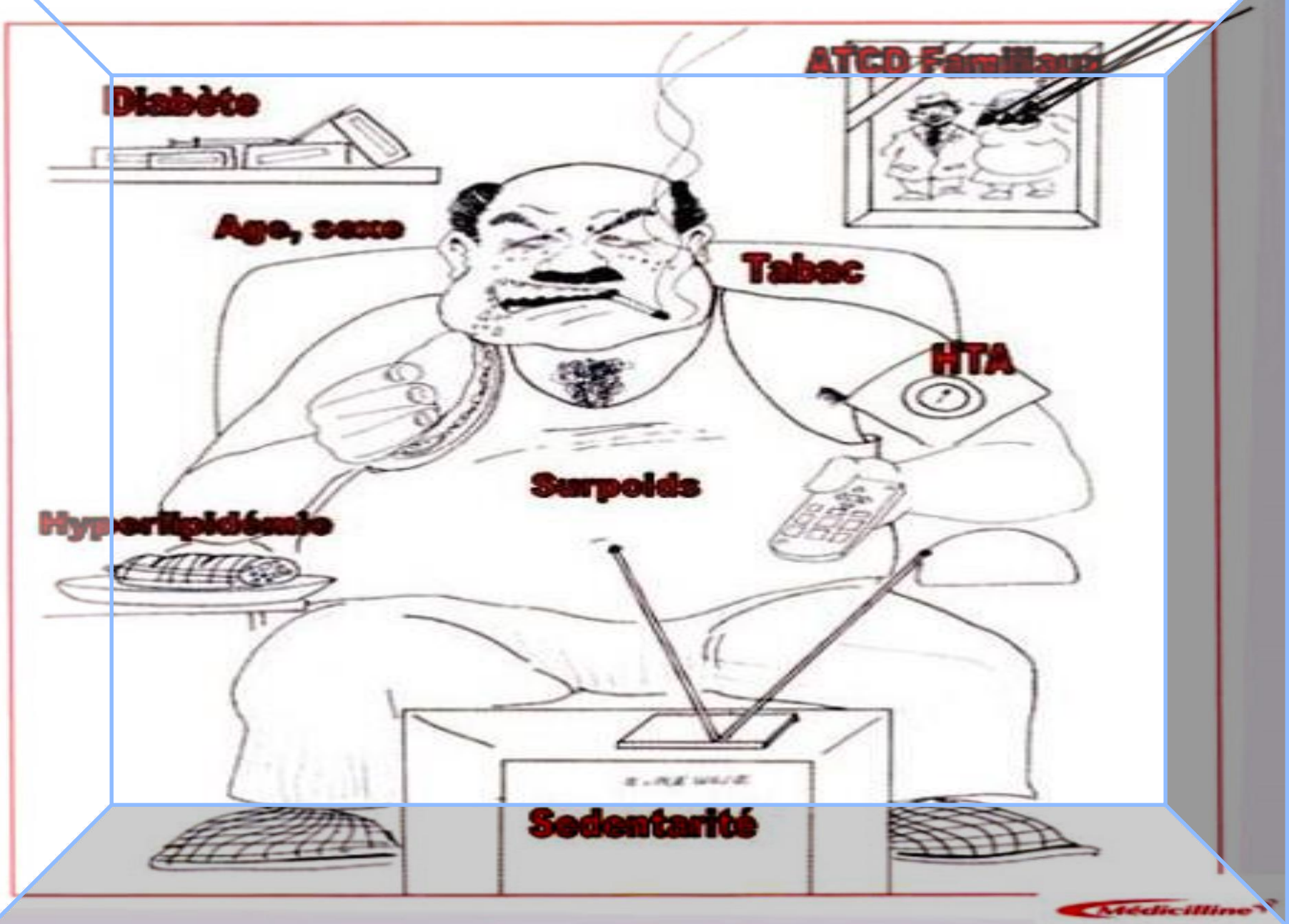
VII. Diagnostic positif



A. Interrogatoire :

- Rechercher les FDRCV.
- Antécédents personnels et familiaux médicaux et chirurgicaux.
- Rechercher d'autres localisations de l'athérosclérose : coronaire et cérébrale.

- Facteur de risques de l'athérosclérose



B. Signes fonctionnels

1) Claudication intermittente d'effort :

- Douleur à type de crampe siégeant au mollet, déclenchée par la marche après une certaine distance, elle disparaît à l'arrêt et se reproduit pour un périmètre fixe
- Il faut préciser :
 - ✓ La distance au bout de laquelle la douleur commence à apparaître: **périmètre de gêne**
 - ✓ La distance à laquelle la marche doit être stoppée: **périmètre de marche.**

2) Douleurs de décubitus: douleurs du pied ou de la jambe surviennent lorsque le patient est allongé, et sont soulagées par la position « jambes pendantes » qui entraîne un œdème de stase aggravant l'insuffisance circulatoire

3) Impuissance sexuelle : Instabilité de l'érection qu'une impuissance.

Un dépistage gratuit aura lieu le
jeudi 8 novembre 2007
à Montpellier, Lille et Grenoble.
Pour tout renseignements, contactez le
CLAVO BREVETÉ

CETTE DOULEUR QUAND VOUS MARCHEZ...

**...et si c'était
vos artères ?**



des pas pour la vie

Parlez de cette douleur à votre médecin. Après 60 ans, le tabagisme, le manque d'activité physique, le diabète ou le surpoids sont des facteurs favorisant les maladies artérielles, pour les femmes comme pour les hommes.



**INSTITUT National
de l'Artère et du Sang**

Adapté



SCV



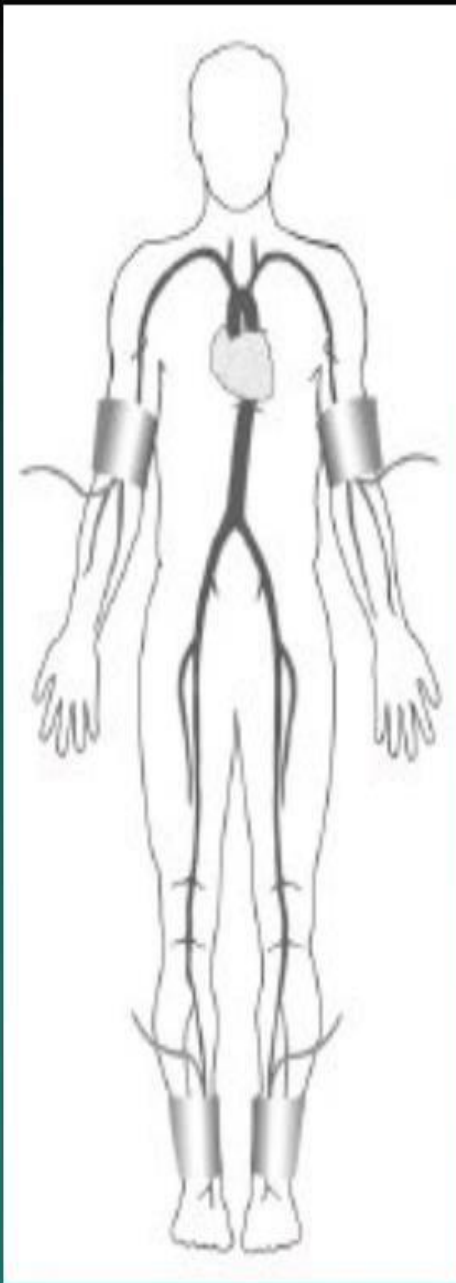
C. Examen physique

- Inspection :
 - La couleur du pied : Normale, pâle ou cyanosée.
 - Recherche des signes d'insuffisance artérielle : Amyotrophie, des ongles cassants, une peau sèche et fissurée, des poils rares.
 - Recherche des troubles trophiques : ulcère, gangrène.
- Palpation:
 - La température cutanée.
 - La palpation des pouls : diminution voir abolition des pouls.
 - Etablir une cartographie lésionnelle.
- Auscultation : souffle systolique de sténose.
- Mesure de la pression artérielle distale = IPS









❖ Mesure des IPS

- Brassard à tension
- Doppler continu (8/10MHz)



IPS=PAS Cheville / PAS Humérale

VALEUR IPS	SIGNIFICATION
0.9 - 1.3	Artères normale
0.75 – 0.9	Artériopathie compensée
0.40 – 0.75	Artériopathie moyennement compensée
< 0.40	Ralentissement sévère

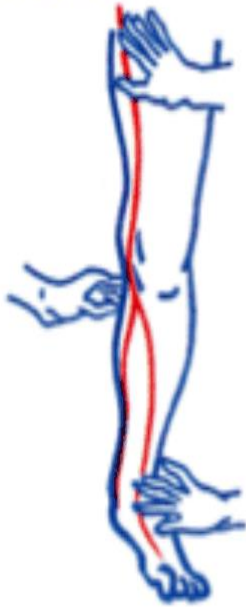
D. Classification

Fontaine et Leriche

STADE	MANIFESTATION
Stade I	Malade asymptomatique
Stade II	Claudication intermittente Stade IIa : claudication légère avec périmètre de marche > à 200m Stade IIb : claudication sévère avec périmètre de marche < à 200m
Stade III	Douleur de repos
Stade IV	Troubles trophiques : ulcère ou gangrène

- **Actuellement on parle d'ischémie critique chronique** : L'association de douleurs de décubitus ou de troubles trophiques **depuis au moins 15 jours** avec une pression artérielle systolique < 50 mm Hg à la cheville ou < 30 mm Hg à l'orteil
- Cette situation clinique comporte un risque d'amputation de membre très élevé.

STADE I



Diminution
des pouls

STADE II



Claudication
intermittente

STADE III



Douleur même
au repos

STADE IV



Troubles trophiques :
ulcérations

VIII. Examens complémentaires

1. Les explorations hémodynamiques :
 - a. Le test de marche sur tapis roulant :
 - ✓ La vitesse du tapis roulant est de 3,2 km/h et la pente de 12 %.
 - ✓ Evaluer le périmètre de gêne et de marche max
 - b. La mesure transcutanée de la pression partielle en oxygène (tcpO_2) :





VALEUR TCP 02	SIGNIFICATION
>60 mmHg	Normal
35-60 mmHg	AOMI compensée
10-35 mmHg	Hypoxie continue
< 10 mmHg	Ischémie critique

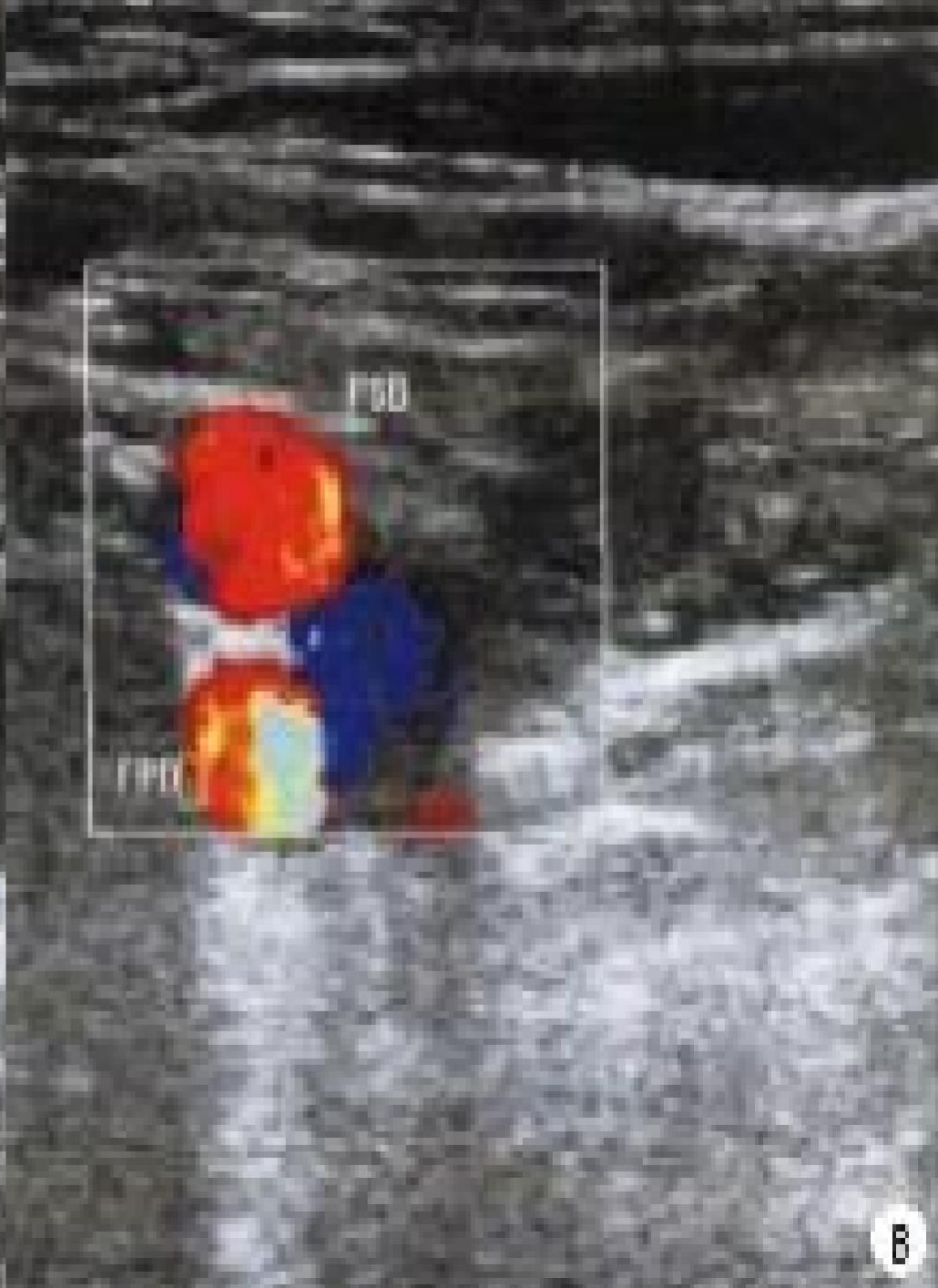
2. Les explorations par ultrasons : L'échographie Doppler

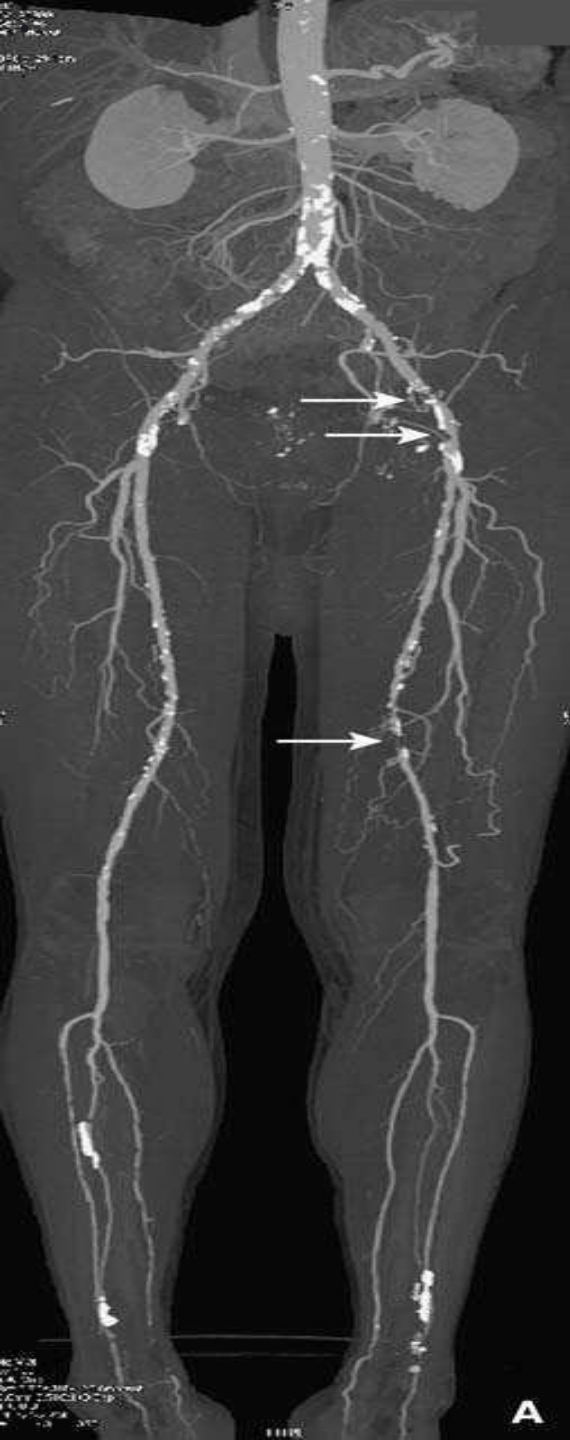
- Examen de première intention
- La localisation précise des lésions, leur étendue, l'état de la paroi
- L'existence d'une circulation collatérale, l'état du réseau d'aval.

3. Les autres techniques d'imagerie :

- Angio-scanner spiralé**: bonne image de l'arbre artériel aortique et des membres inférieures.
- Angio-IRM** : présente l'avantage de ne pas être irradiante, mais elle reste couteuse
- Artériographie** : Examen de référence si un geste de revascularisation est envisagé.

4. Exploration des autres localisations athéromateuses : cardiaque, cérébrale et rénale





IX. Formes cliniques

. **Localisation particulière** : Syndrome de Leriche

- L'occlusion de la bifurcation aortique
- Pâleur, une fatigabilité des deux membres inférieurs, une érection instable et une abolition des pouls fémoraux.

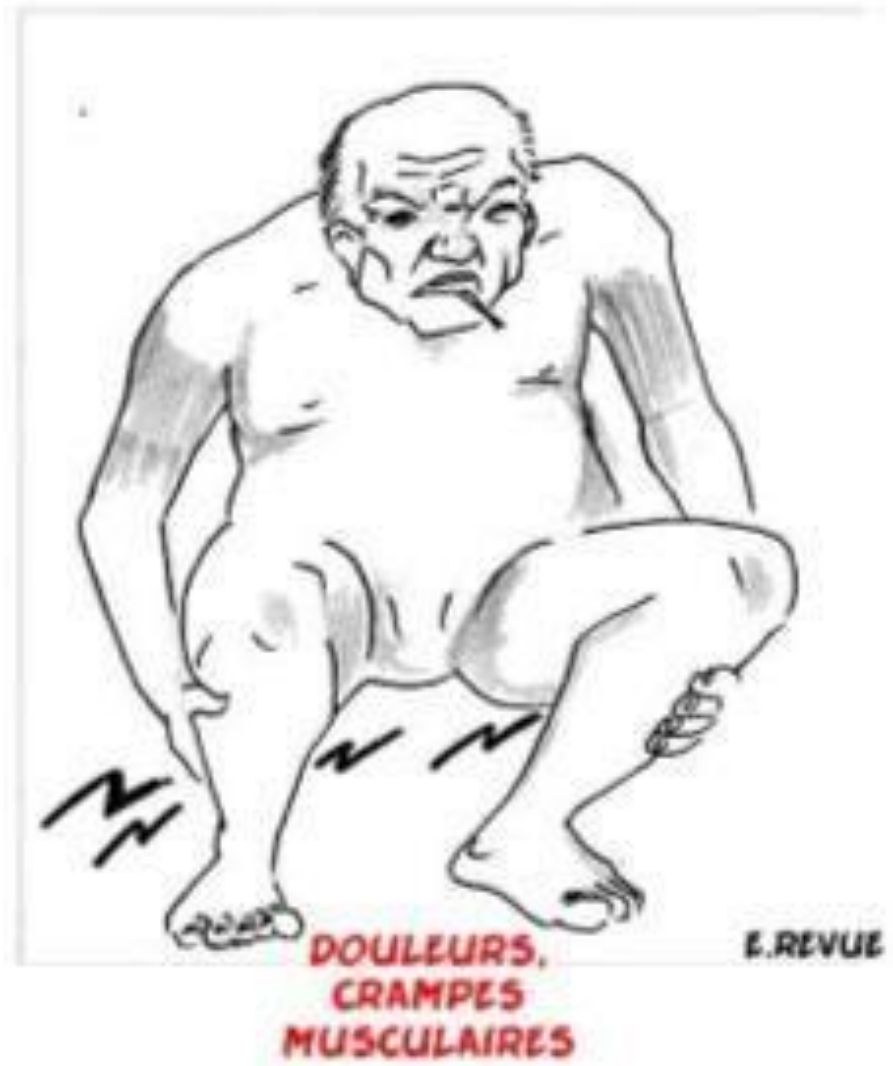
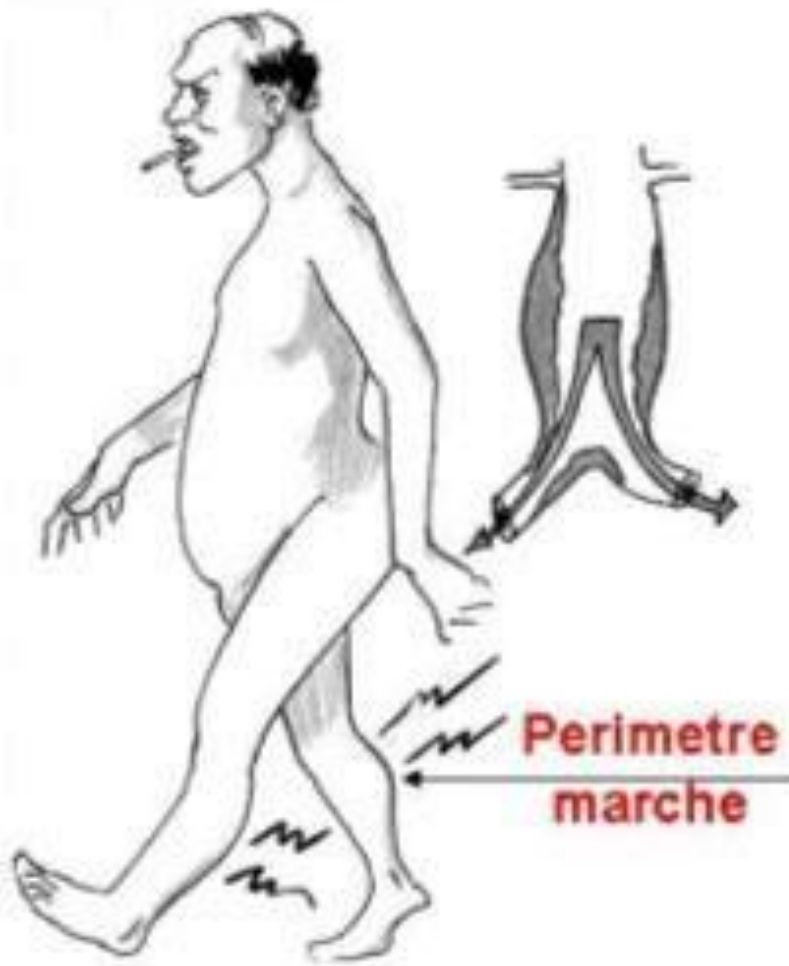
. **AOMI diabétique**

- Les troubles trophiques: l'atteinte artériolaire, neuropathie.
- La gangrène peu algique et surinfectée.
- Le diabète multiplie six fois le risque d'amputation.

. **AOMI emboligène**

- Des migrations emboliques de caillots (fibrine, cholestérol), à partir de plaques ulcérées de l'aorte, artères iliaques ou fémorales.
- Ces emboles peuvent passer inaperçus ou se manifester par des petites taches plantaires purpuriques, un orteil bleu ou encore un livédo.
- Ces migrations risquent de détruire le lit d'aval.

Syndrome de Leriche



X. Diagnostique différentiel

A. Au stade de la claudication :

- Canal lombaire étroit
- Séquelles de phlébite majeure

B. Au stade des troubles trophiques

- Angiodermite nécrotique
- Ulcère veineux de l'insuffisance veineuse superficielle

XI. Complication

- A. **Passage à un stade d'ischémie plus avancé :**
traduit un accident évolutif local (aggravation de l'obstruction artérielle) ou une dégradation de la circulation de suppléance (réduction activité)

- B. **Ischémie aigue**

XII.Traitement

A. Traitement médical:

1. Contrôle des facteurs de risque

- Suppression totale et définitive du tabac
- Traitement d'une HTA, d'une obésité ,d'un diabète
- Marche quotidienne assez lente et prolongée

2. Prévention de la thrombose : le traitement antiagrégant

3. Stabilisation des plaques : statines.

4. Les vasodilatateurs artériels

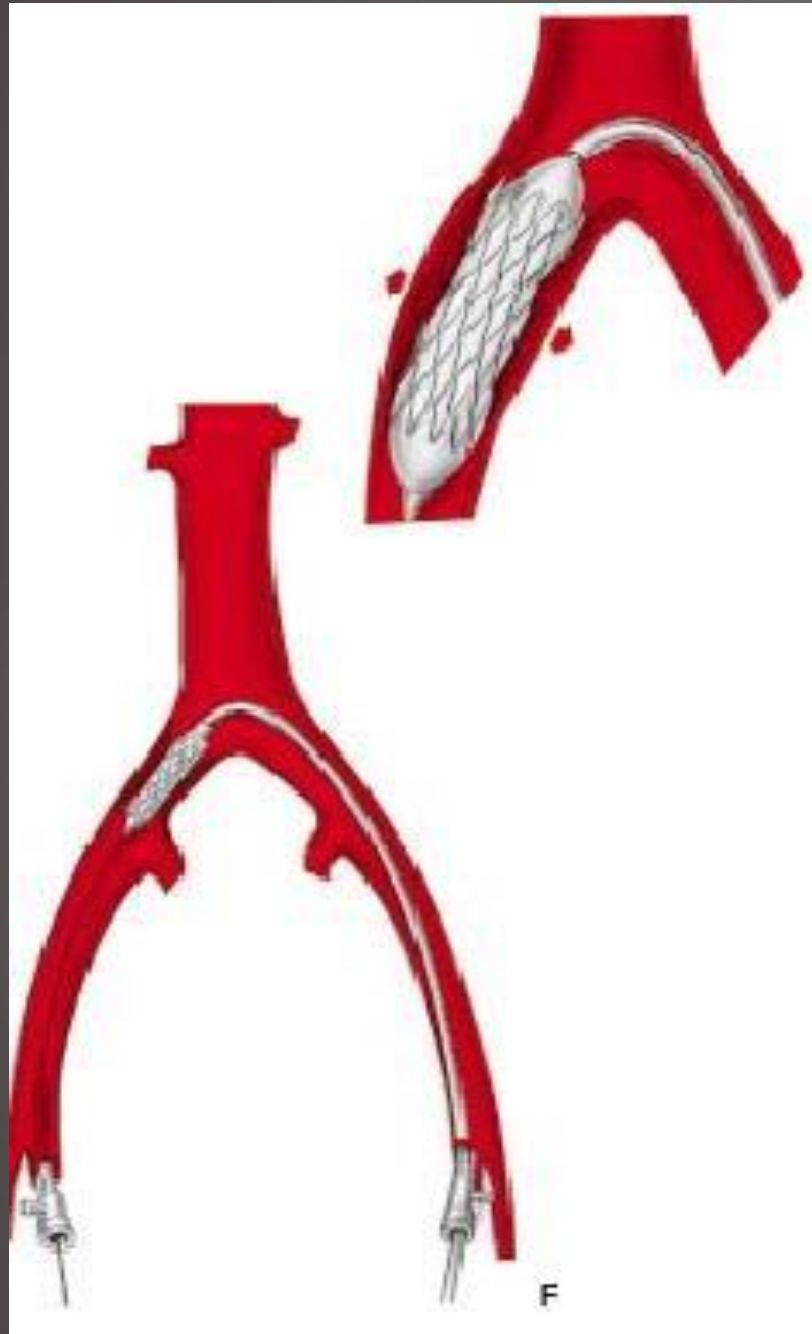
5. Inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC)

6. Soins locaux

7. Le traitement anticoagulant : complications

B. Traitement interventionnel et chirurgical:

1. **Les techniques endovasculaires** : Angioplastie
2. **Endartériectomie** : elle consiste à enlever le séquestre athéromateux.
3. **Les pontages** : Court-circuitent une artère pathologique.
4. **Les amputations**



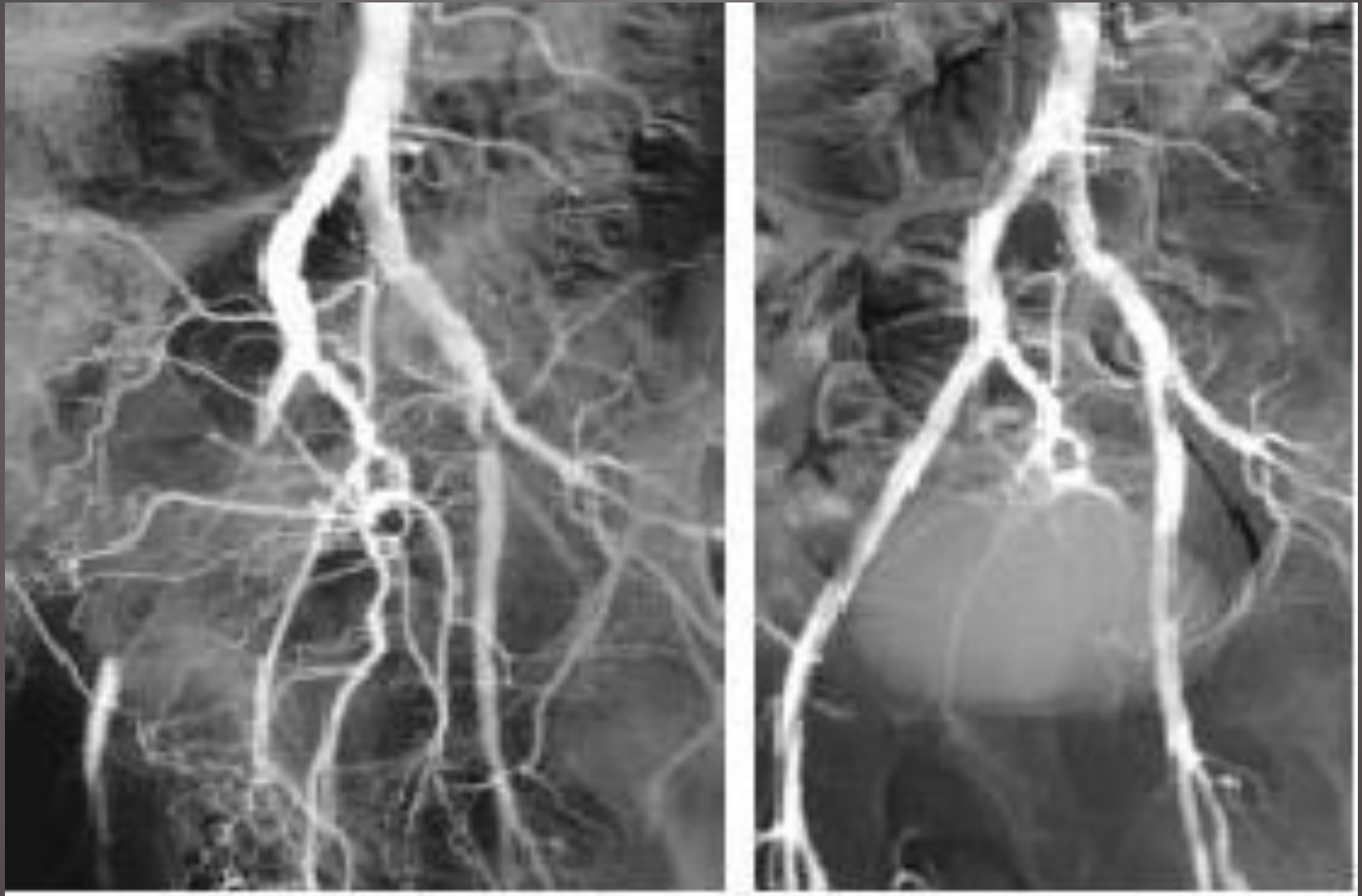
pontage fémoro-poplité

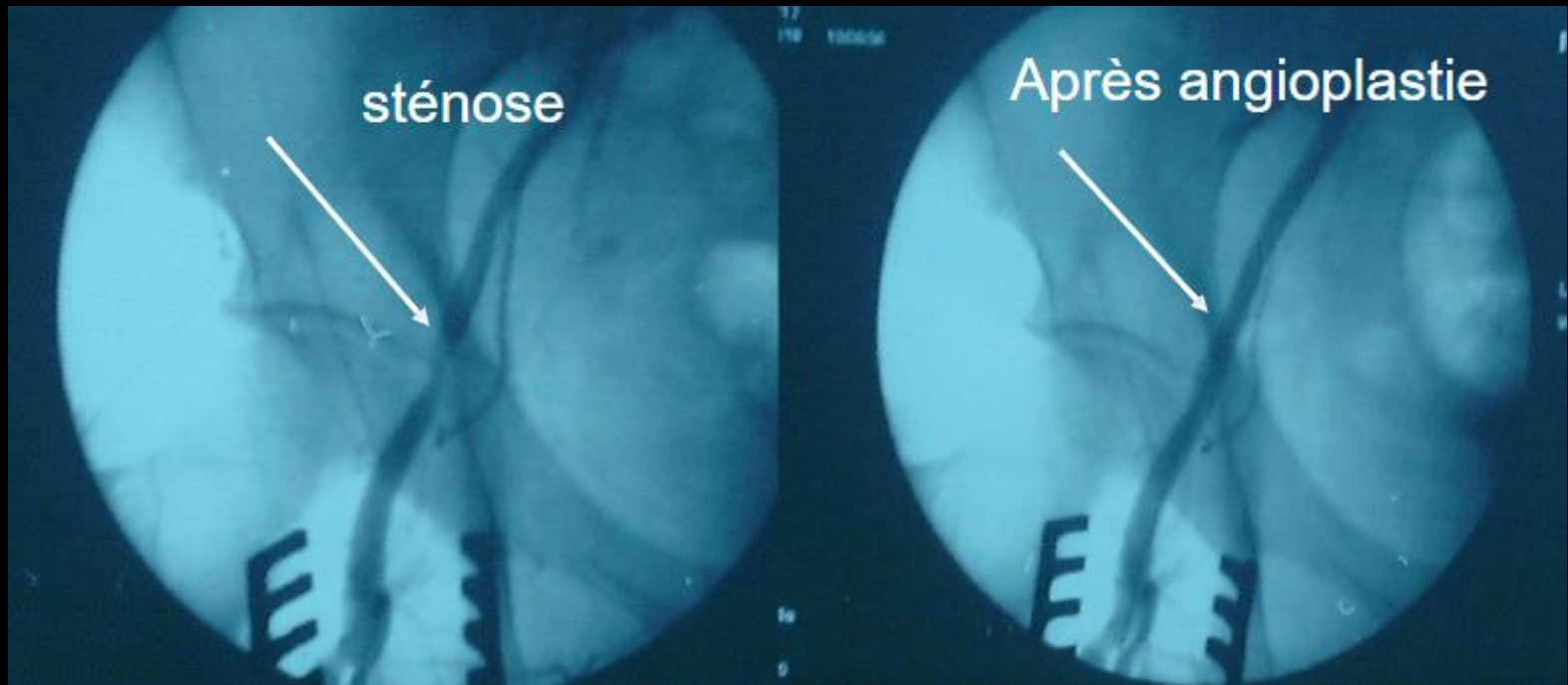
Pontage fémoro-poplité (1) entre l'artère fémorale commune et l'artère poplitée, pour thrombose de l'artère fémorale superficielle (2)

par incision cutanée à l'aîne (3) et incision poplitée au genou (4)



Traitement d'une sténose iliaque par angioplastie





Stent iliaque

C. Indications

Au stade I : correction des facteurs de risque, la marche quotidienne et la prescription d'aspirine

Au stade II :

- le traitement est d'abord médical pendant 6 mois.
- Evolution favorable : continue le traitement médical
- En l'absence d'amélioration : l'angioplastie ou pontage

Au stade III et IV : la revascularisation dans les plus brefs délais s'impose par angioplastie ou chirurgie de revascularisation

En cas de gangrène : l'amputation en urgence est indiquée.

XIII. Conclusion

- L'AOMI est une des expressions de l'athérosclérose.
- Le tabac est le facteur de risque le plus important.
- Le diagnostic clinique est facile.
- Le traitement médical se base sur la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire et la réadaptation par la marche
- La revascularisation est surtout indiquée dans l'ischémie stade III et IV

